

药物相互作用汇集表（二）

镇 惊 药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
镇惊药	安定（苯甲二氮草 Diazepam, Valium）	如以安定作为辅助药用于治疗各种惊厥疾患时，必须增加基础镇惊药的剂量
	卤吡醇	开始用卤吡醇治疗时，镇惊药的剂量可以不变，但随后应酌情调整
	单胺氧化酶抑制剂	单胺氧化酶抑制剂对惊厥阈有程度不等的影响，镇惊药的剂量也应酌情改变
	吩噻嗪类；萝芙木生物碱；硫杂蒽类（Thioxanthenes）	这些药物可降低部分敏感患者的惊厥阈；镇惊药的剂量必须增大
	三环抗抑郁药	大剂量的三环抗抑郁药可促使癫痫发作，镇惊药的剂量应随之改变
巴比妥盐类镇惊药〔乙甲巴比妥（Metharbital, Gemonil），乙戊甲巴比妥（Mephobarbital, Mebaral）苯巴比妥〕	抗凝药	巴比妥盐类可引起酶促作用从而加速抗凝药的代谢
	卤吡醇 吩噻嗪类	这些药物虽可强化巴比妥盐的抑制作用，但镇惊作用并不因此增强
	相互之间	当二种巴比妥盐药物同时服用时，各药的剂量应减为常用剂量的一半
苯妥英钠	对氨基水杨酸	如再与异菸肼（INH）合用，则可抑制苯妥英钠的代谢
	抗凝药	曾报导，双香豆素（Dicumarol）可抑制苯妥英钠的代谢作用，使其作用增强；抗凝药的作用亦可增加
	皮质激素	已证实，苯妥英钠经酶促作用可促进皮质激素的代谢
	双硫醒；异菸肼（Isoniazid, INH）；保泰松；Phenylramidol（Analexin）；磺胺苯吡唑（Sulfaphenazole, Sulfabid）	可抑制苯妥英钠的代谢而增强后者的作用
	利他林	最近报导，利他林可提高苯妥英钠的血浓度
	苯巴比妥	苯妥英钠的作用可因代谢增加（酶促作用）而减弱，但由于苯巴比妥也具有镇惊作用，故一般无临床意义

药名	同服药名	可能产生的相互作用
苯妥英钠	水杨酸盐类	曾报导，大剂量的阿司匹林可增强苯妥英钠的作用
乙妥因 (Ethotoin, Peganone)	苯醋胺 (Phenacemide, Phenurone)	有报导，在二药合并治疗过程中曾出现妄想狂症状，故要审慎给药
苯醋胺	乙妥因	曾报导，出现类妄想狂症状
	其他镇惊药	有过敏反应病史者应特别谨慎

抗 抑 郁 药

药名	同服药名	可能产生的相互作用
单胺氧化酶抑制剂：[闷可乐 (Isocarboxazid, Marplan); 异氮甲苄胍 (Nialamide, Niamid); 苯乙胍 (Phenelzine, Nardil); 反苯环丙胺 (Tranlycypromine, Parnate); 优降宁 (Pargyline, Eutonyl); 呋喃唑酮 (痢特灵, Furazolidone, Furoxone)]	醇	可使醇的作用增强；应避免酒类饮料；曾报导，如与呋喃唑酮并用可产生双硫醒样反应
	苯丙胺 (Amphetamine) 及其衍生物	合并用药会引起高血压危象，故应避免同时服用
	麻醉药	单胺氧化酶抑制剂可增强麻醉药的降压作用，在手术前应停药
	镇惊药	单胺氧化酶抑制剂对惊厥阈有程度不等的影响，因此镇惊药的剂量应当酌情改变
	抗组织胺药	可使抗组织胺药的效应增大
	抗震颤麻痹药	曾报导，同时服用会出现严重反应，因而要谨慎
	巴比妥盐类	巴比妥盐类作用可增强，剂量应减少
	咖啡因	过量的咖啡因可引起高血压反应，故含咖啡因的药物应减量，含咖啡因的饮料亦应适当减少
	亚胺芪	由于亚胺芪的结构与三环抗抑郁药相类似，因此不主张与单胺氧化酶抑制剂同时服用
	中枢神经抑制剂（醇，巴比妥盐类，水合氯醛，ethchlorvynol，镇静剂，安眠药，安定药等）	抑制作用可增强，抑郁药的剂量应减少
	可卡因 (Cocaine)	可卡因的作用可增强
	利尿药（例如噻嗪类）	会出现低血压。须指出，优降宁和 Methyclothiazide 可合并应用，以增强降压作用
	Doxapram (Dopram)	增强加压作用

药 名	同 服 药 名	可 能 生 产 的 相 互 作 用
单胺氧化酶抑制剂	麻黄碱及衍生物	避免同时服用，否则将会出现高血压或类似症状
	二乙香草酰胺 (Ethamivan)	出现加和性兴奋作用
	含有高浓度加压物质， 例如含酪胺的食物（浓缩 的或陈年的干酪、酒、醃 青鱼、鸡肝、罐头无花果、 酵母浸出物、阔豆荚）	加压作用可增强，会出现高血压危象
	神经节阻断剂	由于优降宁可强化这些药物的作用，故不宜同时服用
	胍乙啶 (Guanethidine, Ismelin)	不宜同时服用胍乙啶或至少在单胺氧化酶抑制剂停药一周后才可应用
	降血糖药	降血糖作用增强
	降压药	作用增强，可出现低血压
	甲氧异丁嗪	禁忌合用
	甲基多巴 (Methyldopa, Aldomet)	可出现头痛、高血压及有关症状，应避免合用
	利他林	合并应用时要谨慎
	麻醉药	麻醉作用可增强，剂量应减少
	其他单胺氧化酶抑制剂	二种单胺氧化酶抑制剂不宜同时应用，建议在停用一种药物二周后再用另一种药治疗
	吩噻嗪类	曾有加和性降压作用出现
	普鲁卡因	普鲁卡因作用可增强
	心得安	心得安不宜同时服用或在单胺氧化酶抑制剂停药二周后服用
	萝芙木生物碱	单胺氧化酶抑制剂可抑制萝芙木碱从组织贮存部位所释放的色胺的破坏。故用优降宁治疗期间或其后的周内不宜注射利血平
	拟交感神经兴奋药〔包括 苯丙胺，麻黄碱，苯甲 麻黄碱 (Phenylephrine)， 去甲麻黄碱 (Phenylpro- panolamine) 〕	合并用药可出现严重高血压反应，因此不宜同时服用

药名	同服药名	可能产生的相互作用
单胺氧化酶抑制剂	三环抗抑郁药	三环抗抑郁药不宜与单胺氧化酶抑制剂同时服用或在 MAOI 停药至少二周后才可服用；二者合并用药可引起严重的阿托品样反应、震颤、惊厥和谵妄
三环抗抑郁药[(阿密替林 Amitriptyline, Elavil), 去甲丙咪嗪 (Desipramine), 丙咪嗪 (Imipramine), 去甲替林 (Nortriptyline) 和普罗替林 (Protriptyline)]	醇	醇和三环抗抑郁药的作用均可增强
	抗胆碱能药, 抗震颤麻痹药	由于三环抗抑郁药也具有轻度的抗胆碱能活性, 因而作用有所增强
	镇惊药	大剂量的三环抗抑郁药可促进疾病发作, 镇惊药的剂量应酌情改变
	苯巴比妥盐类及其他中枢神经抑制药	动物试验表明, 三环抗抑郁药可增强巴比妥盐类的作用
	Ethchlorvynol	曾报导, 阿密替林与 Ethchlorvynol 合用可出现一过性谵妄
	呱乙啶	可拮抗呱乙啶的降压作用
	降压药(例如噻嗪类利尿剂, 吩噻嗪类, 血管扩张药)	由于三环抗抑郁药可引起体位性低血压, 故在与其他降压药物同时服用时应注意观察
	甲基多巴	降压作用减弱
	利他林	最近报导, 利他林可破坏丙咪嗪和去甲丙咪嗪的代谢作用
	单胺氧化酶抑制剂	三环抗抑郁药不宜与单胺氧化酶抑制剂同时服用或至少停药 MAOI 二周后才可应用；二者合并用药可引起严重的阿托品样反应、震颤、惊厥和谵妄
	去甲肾上腺素	三环抗抑郁药可增加去甲肾上腺素的加压作用
	吩噻嗪类	三环抗抑郁药与吩噻嗪(例如 Etrafon 和 Triavil)常合用于治疗躁动型抑郁症
	保泰松	大白鼠试验表明, 丙咪嗪或去甲丙咪嗪可抑制保泰松的肠道吸收作用
	利血平	三环抗抑郁药可阻断或逆转利血平的抑制作用
	拟交感神经兴奋药	三环抗抑郁药和拟交感神经兴奋药的作用均可增强
	甲状腺制剂	两种药物的作用均增强

抗 组 织 胺 药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
抗组织胺药	口服抗凝药	抗组织胺药可减弱抗凝药的作用
	抗胆碱能药	由于许多抗组织胺药都具有抗胆碱能活性，故作用可增强
	甲氨乙吡啶 (Betahistine, Serc)	甲氨乙吡啶是组织胺样物质，故不主张与抗组织胺药合并应用
	中枢神经抑制药(醇，镇静药，催眠药，麻醉药，安定药等)	镇静作用增强
	单胺氧化酶抑制剂	由于单胺氧化酶抑制剂可抑制抗组织胺药的代谢，而使作用增强
Chlorvocizine 和苯海拉明 (Diphenhydramine, Benadryl)	巴比妥盐类	Chlorcycizine 和苯海拉明以及其他抗组织胺药均可引起酶促作用而使巴比妥盐类的活性减弱，但镇静作用在开始时却增强
	皮质激素(以及其他能被肝微粒体酶代谢的药物)	因酶促作用使皮质激素效应减弱
茶苯海明(晕海宁 Dimenhydrinate, Dramamine)	卡那霉素；新霉素；链霉素	茶苯海明可掩盖这些抗菌素引起的耳中毒症状
吩噻嗪类抗组织胺药——见安定药项下吩噻嗪类		

抗 感 染 药

驱 虫 药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
哌嗪 (Piperazine, Antepar)	吩噻嗪	可能增大锥体外系的反应
四氯乙烯 (Tetrachloroethylene)	醇	四氯乙烯可引起酩酊症状，醇可增强这种反应，所以在用药前后24小时内不宜饮酒

抗 菌 素

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
二性霉素乙 (Amphotericin B, Fungizone)	抗菌素; 抗代谢物; 皮质激素; 氮芥 (Mechlorethamine, Mustargen)	用过这些药物的患者有时会出现深部真菌感染; 除非绝对控制二性霉素的反应或必须用于治疗原发疾病, 否则这些药物不宜与二性霉素乙同时应用
氯霉素	青霉素	氯霉素为抑菌剂, 而青霉素为杀菌剂; 由于青霉素仅对增殖性细菌有效, 故氯霉素可抑制其抗菌作用
	其他抑制骨髓的药物	应避免同时应用
	苯巴比妥	动物试验表明, 先以苯巴比妥治疗会降低氯霉素的血浓度及其化疗活性
粘菌素 (Colistimethate, Coly-Mycin M) 和多粘菌素乙 (Polymyxin B, Aerosporin)	肌肉松弛药, 卡那霉素; 新霉素; 链霉素; 双氢链霉素	这些药物可干扰神经肌接合部位的神经传递; 由于粘菌素和多粘菌素乙也能引起这种反应, 故只能谨慎地与其中的一种药物同用, 否则会影响神经肌肉传递, 导致肌无力和呼吸暂停
红霉素 (Erythromycin, Erythrocin, Ilosone)	尿道碱化剂	红霉素的抗菌活性随着尿的 pH 变为碱性而增强
	林可霉素 (Lincomycin, Lincocin)	体外试验报导, 红霉素和林可霉素间有拮抗作用
	羧苯磺胺	动物试验证实, 羧苯磺胺抑制红霉素在肾小管的再吸收
灰黄霉素	口服抗凝药	灰黄霉素可引起酶促作用, 使抗凝药的代谢加速, 因此抗凝药的剂量必须增大
	巴比妥盐类	已证实, 苯巴比妥可引起酶促作用而使灰黄霉素的作用减弱
卡那霉素; 新霉素; 链霉素	麻醉药; 肌肉松弛药	这些抗菌素与麻醉药或肌肉松弛药同时腹腔注射时, 可发生神经肌肉麻痹和呼吸抑制; 因此患者在用麻醉药或肌肉松弛药尚未完全苏醒前不宜用这些抗菌素
	尿道碱化剂	碱性尿可增强尿道的抗菌活性; 但仅在用链霉素治疗尿道感染时, 才需要碱化尿液
	茶苯海明 晕海宁	晕海宁可掩盖这些抗菌素引起的耳中毒症状
	相互之间	这些药物在同时或顺序给药时可能发生累积性耳中毒症状

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
林可霉素	含有甜精 (Cyclamate) 的饮料 止泻果胶(Kaopectate)	可明显地降低林可霉素在胃肠内的吸收；因此建议在口服林可霉素的前后一二小时内，除饮水外不宜进食
	红霉素	体外试验表明，红霉素和林可霉素间有拮抗作用
青霉素类	抑菌性抗菌素（氯霉素，磺胺，四环素等）	青霉素为杀菌药，但仅对繁殖性细菌有效，抑菌性抗菌素可抑制青霉素类抗菌素的抗菌作用
	放线菌素 D (Dactinomycin, Cosmegen)	体外试验表明，青霉素G的杀菌作用可被拮抗
	羧苯磺胺	由于羧苯磺胺能干扰青霉素G的肾小管排泄和减少其分布容积，故可增强青霉素衍生物的作用
四环素	抗凝药	抗凝药的作用增强；其作用的发挥部分是由于干扰了胃肠道内维生素K的生物合成所致
	阳离子（二价和三价化合物例如 Ca^{++} ， Mg^{++} 及 Al^{+++} ） 制酸剂 牛奶	这些阳离子在胃肠道内可与四环素形成难于吸收的络合物；但应指出，同时给予牛奶，对强力霉素 (Doxycycline, Vibramycin) 的吸收并无显著影响
	肝脏毒性药物	已知四环素可引起肝脏损害；如静脉注射四环素时，其它可能的肝脏毒性药物应尽量避免合用
	青霉素	青霉素为杀菌药，仅对繁殖性细菌有效，四环素为抑菌药可抑制青霉素的杀菌作用

抗 疟 药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
氯喹和羟基氯喹	肝脏毒性药物	已知氯喹浓集于肝脏，如在应用肝脏有毒性药物时，给药必须谨慎
	保泰松	保泰松以及其他可引起过敏和皮炎的药物都不宜与氯喹或羟基氯喹一起合用
伯氨喹	阿的平	不宜同时服用伯氨喹与阿的平，对最近服过阿的平的患者，也不宜给予伯氨喹，否则毒性将会增大
奎宁	抗凝药	奎宁能抑制肝内凝血酶原的形成，故抗凝药的作用增强

抗 结 核 药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
抗结核药	皮质激素	结核病患者一般禁用皮质激素，但在某些病例由于激素与抗结核药同用而得救
	相互之间	建议几种抗结核药合并应用以提高治疗效果及减少细菌的耐药性
对氨基水杨酸	苯妥英钠	如对氨基水杨酸与异菸肼合用，苯妥英钠的代谢可受抑制
	异菸肼	对氨基水杨酸可增加和延长异菸肼的血浓度
	羧苯磺胺	羧苯磺胺可减少对氨基水杨酸的尿排泄从而提高其血浆浓度
	水杨酸盐类	水杨酸盐中毒的危险性增大
异菸肼	对氨基水杨酸	对氨基水杨酸可增加和延长异菸肼的血液浓度
	苯妥英钠	苯妥英钠的作用可因代谢受抑而增强

抗 病 毒 药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
金刚烷胺	中枢神经兴奋药 精神药物	由于金刚烷胺有中枢神经和精神方面的副作用，故这些药物合用时必须审慎
碘贰	硼酸	硼酸在碘贰存在的情况下有刺激作用，故在用后者治疗期间不宜用硼酸
	皮质激素	皮质激素可促进病毒感染的扩散，除非绝对需要，不宜与碘贰合用

磺 胺 类 药 物

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
磺胺类	尿道碱化剂	应用某些老的磺胺药（如磺胺嘧啶等）时需要碱化小便以防结晶尿发生；由于磺胺是弱酸性，碱化尿可增加磺胺药的排泄率，同时药物的作用也可能降低

药名	同服药名	可能产生的相互作用
磺胺类	对氨基苯甲酸 (PABA)	磺胺为有效的抗菌药，可与 PABA 竞争并阻止微生物对 PABA 的正常利用；如 PABA 浓度增高，则磺胺的活性下降。某些具有 PABA 母核的局部麻醉药可能都有相同的作用
	制酸药	减少磺胺在胃肠道的吸收
	口服抗凝药	抗凝药作用的增强，部分原因可能是由于蛋白结合部位被置换以及胃肠道内维生素K的生物合成受到干扰所致
	苯妥英钠	曾报导，磺胺苯吡唑 (Sulfaphenazole) 可抑制苯妥英钠的代谢，而使后者的作用增强
	乌洛托品	乌洛托品仅在酸性尿中有效；磺胺在酸性尿中不易溶解，并可产生结晶尿
	甲氨喋呤	磺胺可置换白蛋白结合部位上的甲氨喋呤，从而使后者的毒性增加
	青霉素	磺胺为抑菌药而青霉素为杀菌药，青霉素仅对繁殖性细菌有效，因此磺胺可抑制青霉素的抗菌作用
	羟基保泰松，保泰松	磺胺的活性可因蛋白结合部位被置换而增加
	羧苯磺胺	羧苯磺胺可增加血浆中总磺胺浓度
	磺胺吡唑二酮	磺胺的作用可增强
	磺酰脲	降血糖效应可能由于蛋白结合部位被置换而增强；最多的报导是关于磺胺苯吡唑与甲磺丁脲应用研究

其它抗炎剂

药名	同服药名	可能产生的相互作用
呋喃唑酮-见抗抑郁药项下的单胺氧化酶抑制剂		
乌洛托品	尿道碱化剂	乌洛托品释放甲醛及生效需要酸性尿的条件；碱化小便可降低其作用
	磺胺	磺胺在乌洛托品生效的酸性尿中不易溶解；如与某些磺胺合用时可发生结晶尿
灭滴灵(硝基羟乙唑)	醇	曾报导，饮酒后可出现双硫醒样反应
	双硫脲	合并应用可导致急性精神病或精神错乱

降 血 脂 药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
安妥明	口服抗凝药	抗凝药的效应增加, 开始用安妥明治疗时, 抗凝药的剂量应减少1/3至1/2
	磺酰脲	在用安妥明治疗糖尿病时应细心观察。有报导, 在服甲苯磺丁脲的患者中, 曾有降血糖作用增强的情况
右旋甲状腺素腺	口服抗凝药	抗凝药作用增强, 可能由于对受体部位的亲和性增大所致; 开始用右旋甲状腺素治疗时抗凝药的剂量应当减少1/3, 随后酌量调整
	肾上腺素	冠心病患者注射肾上腺素可促进冠状动脉机能不全发生; 服右旋甲状腺素的患者发生这种情况的机会增多
	降血糖药	右旋甲状腺素可增加血糖量, 故降血糖药的剂量应增大
	甲状腺制剂	其他甲状腺制剂的剂量可酌情改变

镇 咳 药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
Chlrophedianol (ULo)	中枢神经抑制药或兴奋药	Chlrophedianol 为中枢作用药, 故与其他这类药物合用时必须谨慎
Pipazethate (Theratussa)	巴比妥盐类	Pipazethate 的化学结构与吩噻嗪相类似; 故巴比妥盐类的活性可能增强

支 气 管 扩 张 药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
黄嘌呤制剂[胆茶碱(Choledyl), Elixophyllin, Quibron 等]	口服抗凝药 其它黄嘌呤制剂 拟交感神经兴奋药	大剂量黄嘌呤衍生物可改变抗凝药的作用 可发生明显的中枢神经兴奋作用

中 枢 神 经 兴 奋 药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
中枢神经兴奋药	金刚烷胺	金刚烷胺有中枢神经副作用，合并用药必须审慎
Doxapram	单胺氧化酶抑制剂	因加压作用增强，这些药物与 Doxapram 合用时必须审慎
	拟交感神经兴奋药 环丙烷 卤烷（氟烷）	Doxapram 可增加肾上腺素的释放；由于这些麻醉药可使心肌对儿茶酚胺敏感，故必须在麻醉药停用后才可服用 Doxapram
二乙香草酰胺	单胺氧化酶抑制剂	可加和兴奋作用
利他林	口服抗凝药	抗凝药的作用可因代谢受抑制而增强
	苯妥英钠	利他林可增加苯妥英钠的血浓度
	胍乙啶	可使胍乙啶的降压作用减弱
	单胺氧化酶抑制剂	合并用药必须谨慎
	升压药	升压作用增强
	三环抗抑郁药	曾报导，利他林可影响丙咪嗪和去甲丙咪嗪的代谢

洋 地 黄 甙

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
洋地黄甙	钙盐(注射给药)	钙浓度升高可使心脏对洋地黄的敏感性增大
	利尿药[噻嗪类，速尿灵或腹安酸 (Furosemide, Lasix) 利尿酸 (Ethacrynic acid, Edecrin 等)]	利尿药可引起低血钾症，如失钾不予补充，则心脏对洋地黄的作用更为敏感，可能会出现洋地黄中毒
	胍乙啶	二种药物均可使心率减慢
	异丙肾上腺素(喘息定) (Isoproterenol, Isuprel)	异丙肾上腺素禁用于洋地黄中毒引起心动过速的患者

药名	同服药名	可能产生的相互作用
洋地黄甙	钾盐；螺旋内脂(安体舒通, Spironolactone, Aldactone); 氨苯喋啶 (Triamterene, Dyrenium)	螺旋内脂和氨苯喋啶均为贮钾利尿药，血钾过高可减弱洋地黄的效应
	萝芙木衍生物	患者同时服用洋地黄时较易出现心律不齐
	藜芦生物碱	

利 尿 药

药名	同服药名	可能产生的相互作用
噻嗪类(氯噻酮, 利尿酸, 速尿灵和 Quinethazone)	醇	可能引起体位性低血压
	氯化铵	对肝功能不全患者不宜用氯化铵来纠正利尿药所引起的低氯性碱中毒
	巴比妥盐类	可引起体位性低血压
	皮质激素 促肾上腺皮质激素	由于这类药物和利尿药都可引起低血钾，故可使钾大量丢失
	洋地黄	利尿药可引起血钾减低，如失钾不予补充，则心脏对洋地黄的作用更为敏感，可能引起洋地黄中毒
	降血糖药	利尿药可提高血糖水平，故需增大降血糖药的剂量
	降压药	降压作用增强；利尿药常可减少降压药的用量
	单胺氧化酶抑制剂	可发生低血压；如将优降宁和 Methyclothiazide 合用以增强降压作用时必须注意
	麻醉药	可引起体位性低血压
	去甲肾上腺素	动脉对去甲肾上腺素的反应性减弱
	钾盐	钾盐常用来纠正利尿药引起的低血钾；应尽可能避免用肠溶衣钾盐，否则会发生小肠溃疡
	螺旋内酯	氨苯喋啶和螺旋内酯都是贮钾利尿药，可与其他利尿药同用以减少钾的丢失和增强利尿作用
	筒箭毒碱	利尿药可增强筒箭毒碱的作用
汞利尿剂	利尿酸制剂	利尿药可减少尿酸的肾排泄，故需增大利尿酸的剂量
	氯化铵	汞利尿剂可引起氯性碱中毒，而使利尿药的效果减弱；服用氯化铵可恢复汞利尿剂的效应

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
螺旋内酯和氨苯喋啶	其它利尿剂	螺旋内酯和氨苯喋啶常常与噻迭氮物类利尿药合用以减少钾丢失和增强利尿作用
	降压药	降压作用增强
	相互之间	可发生高血钾

酶 类 制 剂

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
菠萝蛋白酶	抗凝药	抗凝作用增强
糜蛋白酶—胰蛋白酶	抗凝药	合并应用时必须注意观察
由番木瓜提取的水解蛋白酶 (Papase)	抗凝药	禁忌合用
链激酶 (Streptokinase,Varidase) 链道酶(Streptodornase)	抗菌素	肌肉注射链激酶时应伴以一种广谱抗菌素

胃 肠 道 药

名 药	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
制酸药	酸性药物(磺胺等)	因制酸药提高pH,使胃肠道对弱酸的吸收减少
	口服抗凝药	大剂量的制酸药可抑制抗凝药的吸收,而使其作用减弱
	碱性药[如苯丙胺,度冷丁(Meperidine,Demerol)]	因制酸药提高pH,使胃肠道对弱碱的吸收增多
	皮质激素类	皮质激素类可引起胃酸过多或消化性溃疡;如长期给药,应予制酸药预防之
	肠溶衣药剂[吡啶亚甲双酚酸酯(Bisacodyl,Dulcolax)]	增加pH可使肠溶衣在胃内崩解和释放药物;许多肠溶衣药物均有刺激性,可引起恶心和呕吐
	四环素类	制酸药的阳离子与四环素可形成难吸收的络合物

止 泻 药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
Diphenoxylate, Lomotil 和阿托品合剂	巴比妥盐类	巴比妥盐类的作用增强

泻 药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
吡啶亚甲双酚酸酯	制 酸 药	在服用制酸药后的一小时内不宜用吡啶亚甲双酚酸酯, 否则肠溶衣崩解, 药物在胃内释放可引起刺激和呕吐
二辛基硫化琥珀酸钠 (Dioctyl sodium sulfosuccinate, Colace)和Polyoxalkol	矿 物 油	可增加矿物油的吸收, 不宜长期同时使用
矿 物 油	口服抗凝药	在少数情况下发现抗凝药的作用有不同的改变
	二辛基硫化琥珀酸钠	这些表面活性剂可增加矿物油的吸收, 不宜同时长期使用
	维生素类	长期服用矿物油可减少脂溶性维生素A、D、E、K的吸收

(续 续)

一 九 七 五 年 订 阅 通 知

《新医药通讯》是以反映我市医药卫生科技动态为主的内部双月刊物。逢双月二十五日出版。广东省内发行。每册订价0.26元, 全年6期, 共1.56元。代号: 46—34。

我省内医药卫生、医药生产供应、科研情报、医药院校及有关单位需订阅者, 均可凭单位介绍信到广东省各地邮局订阅。

《新医药通讯》编辑组

一九七四年十月